

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE ORIENTACIÓN VITAL REVISADO (LOT-R)

Eje III: Personalidad • Evaluación Dimensional del Optimismo Disposicional vs. Pesimismo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Orientación Vital Revisado (LOT-R: 10 reactivos).
Nombre Original	Life Orientation Test-Revised (LOT-R; Scheier, Carver & Bridges, 1994).
Autores Originales	Dr. Michael F. Scheier, Dr. Charles S. Carver y Dr. Michael W. Bridges.
Adaptaciones Hispanas	Ferrando et al. (2002), Univ. Rovira i Virgili; Otero et al. (1998); Remor et al. (2006).
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad. Optimismo disposicional, expectativas de resultado y pesimismo.
Tipo de Instrumento	Autoinforme breve de 10 reactivos (6 evaluativos y 4 distractores) con escala Likert de 5 puntos (0 a 4).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (13 a 85 años). Población general, clínica y psicomedicina.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Dominio público científico de libre aplicación clínica y de investigación bajo citación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DEL OPTIMISMO DISPOSICIONAL

El **Optimismo Disposicional** se define en el marco del modelo autorregulatorio de la conducta (Scheier & Carver, 1985, 1994) como una expectativa generalizada, global y relativamente estable de que ocurrirán cosas positivas en la vida (“expectativas generalizadas de resultado positivo”).

A diferencia de los estilos atributivos situacionales, el optimismo disposicional opera como un rasgo nuclear de personalidad que modula cómo las personas afrontan las dificultades: los optimistas emplean estrategias de afrontamiento orientadas al problema, aceptación constructiva y reevaluación positiva, mientras que los pesimistas tienden a la negación, la desconexión conductual y el abuso de sustancias.

A nivel neurobiológico, el optimismo se asocia a una mayor reactividad y conectividad funcional entre la corteza prefrontal ventromedial y el estriado ventral (núcleo accumbens) durante el procesamiento de expectativas futuras placenteras, así como a una atenuación de la actividad en la amígdala ante estímulos negativos anticipatorios. Asimismo, predice una respuesta inmunológica más robusta (mayor actividad de células NK y menor inflamación por IL-6) y una menor reactividad cardiovascular del eje simpatoadrenal frente a estresores de laboratorio.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Dimensión / Reactivos	Ítems (10)	Nº Ítems	Definición Operativa y Ponderación
1. Optimismo (Directos)	1, 4, 10	3 ítems	Expectativas favorables generalizadas de futuro y confianza adaptativa.
2. Pesimismo (Invertidos *)	3*, 7*, 9*	3 ítems	Anticipación sistemática de fracaso, desesperanza y fatalismo.
3. Ítems Relleno (Neutros)	2, 5, 6, 8	4 ítems	Distractores de relleno diseñados para enmascarar el constructo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Satisfactoria en adaptaciones españolas (Ferrando et al., 2002; Remor et al., 2006): coeficiente alfa de Cronbach de 0.78 a 0.84 para la escala total de 6 ítems puntuables. Subescala Optimismo: alpha = 0.74; Subescala Pesimismo: alpha = 0.76. Estabilidad temporal test-retest $r = 0.79$ a 6 meses.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio respalda un modelo bidimensional correlacionado (Optimismo y Pesimismo como factores sustantivos parcialmente independientes, $r = -0.52$; CFI = 0.98, RMSEA = 0.045), así como un modelo unidimensional bipolar de Optimismo General.
Validez Concurrente	Correlación directa significativa con Autoeficacia General (GSE, $r = 0.54$), Autoestima (RSES, $r = 0.58$), Afecto Positivo (PANAS, $r = 0.49$) y Calidad de Vida (SF-36). Correlación inversa con Neuroticismo (NEO-PI-R, $r = -0.50$), Ansiedad Rasgo (STAI, $r = -0.56$) y Depresión (PHQ-9, $r = -0.52$).
Poder Predictivo	Predictor independiente robusto de recuperación postquirúrgica, adherencia al tratamiento médico en enfermos crónicos y menor morbilidad cardiovascular.
Invarianza de Medida	Invarianza configuracional y métrica ratificada por sexo y tramos de edad en muestras comunitarias y hospitalarias españolas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 10 reactivos se califica en una escala Likert de 5 puntos (0 a 4):

- **Opciones de Respuesta:** 0 = «Muy en desacuerdo», 1 = «En desacuerdo», 2 = «Neutro / Ni de acuerdo ni en desacuerdo», 3 = «De acuerdo», 4 = «Muy de acuerdo».
- **Paso 1 (Exclusión de Reactivos Rellenos):** Los ítems 2, 5, 6 y 8 son distractores y **no se computan**.
- **Paso 2 (Inversión de Ítems de Pesimismo):** Los reactivos 3, 7 y 9 se invierten para orientarlos a optimismo:

$$\text{Ítem Invertido} = 4 - \text{Respuesta Original}$$

(De modo que: 0 pasa a 4; 1 pasa a 3; 2 permanece 2; 3 pasa a 1; 4 pasa a 0).

- **Paso 3 (Puntuación Total LOT-R):** Suma de los 6 reactivos evaluativos:

$$\text{Puntuación Total} = \text{Ítem 1} + \text{Ítem 4} + \text{Ítem 10} + (4 - \text{Ítem 3}) + (4 - \text{Ítem 7}) + (4 - \text{Ítem 9})$$

- **Rango Total Teórico: 0 a 24 puntos.** A mayor puntuación, mayor nivel de optimismo disposicional.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación Total	Nivel de Optimismo	Interpretación y Recomendación Clínica
Bajo / Pesimista	0 a 13 puntos	Pesimismo disposicional (≤ 13)	Predisposición a expectativas catastrofistas, desesperanza y pasividad. Intervención en reestructuración.
Moderado / Medio	14 a 18 puntos	Optimismo normativo	Adecuada flexibilidad de expectativas; balance realista entre esperanza y cautela ante riesgos.
Alto / Resiliente	19 a 24 puntos	Alto optimismo disposicional	Expectativas positivas sólidas, proactividad resolutive y elevada resistencia al estrés psicofísico.

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DEL PESIMISMO (CORTE ≤ 13 PUNTOS):

Un LOT-R ≤ 13 señala un factor de riesgo psicofisiológico mayor en pacientes con enfermedades crónicas (cardiopatías, dolor oncológico) y predice una menor persistencia en hábitos de salud, mayor abandono de pautas farmacológicas y elevada propensión a cuadros afectivos reactivos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN ATRIBUCIÓN Y EXPECTATIVAS

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN SESGO PESIMISTA:

- **Paso 1 (Identificación del Estilo Expectante):** Si LOT-R ≤ 13 , desglosar ítems de pesimismo (3, 7, 9). Evaluar si el paciente anticipa el fracaso como certeza ineludible o como mecanismo de protección ansiosa ("pesimismo defensivo").
- **Paso 2 (Reestructuración de Atribuciones y Descatastrofización):** Cuestionar la certeza del desenlace negativo mediante el examen de probabilidades objetivas y registro de predicciones fallidas.
- **Paso 3 (Activación Orientada al Problema):** Entrenar al paciente en sustitución de la evitación pasiva por afrontamiento activo centrado en el problema y en valores de autocuidado (ACT).
- **Paso 4 (Consolidación y Criterio de Alta):** Un incremento de ≥ 5 puntos en el LOT-R o alcanzar el rango de optimismo normativo (≥ 14) consolida el cambio de actitud vital.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN TRAS DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN Y FATIGA

Identificación: Varón de 51 años, docente de secundaria, derivado por cardiología por descontrol tensional y abandono de las recomendaciones higiénico-dietéticas. El paciente expresa convicción de que "haga lo que haga, mi salud va a empeorar porque en mi familia todos han muerto jóvenes".

Evaluación Inicial LOT-R (Línea Base): Puntuación Total = **7/24 puntos** (Rango de Pesimismo Disposicional Marcado). Desglose: Optimismo = **2/12 puntos** (ítems directos puntuados 0 y 1); Pesimismo = **5/12 puntos** (máxima anticipación de desgracias en ítems 3, 7 y 9).

Plan Terapéutico: 8 sesiones de Terapia Cognitiva en Psicología de la Salud. Se desmontó el fatalismo hereditario distinguiendo entre predisposición genética y factores conductuales modificables, prescribiendo experimentos conductuales de actividad física moderada.

Reevaluación a los 2 Meses: Puntuación Total LOT-R ascendió a **16/24 puntos** (+9 pts, Rango de Optimismo Normativo). El paciente restableció la toma de medicación, incorporó caminatas diarias regulares y estabilizó sus cifras de presión arterial en rango normal.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

PESIMISMO PROFUNDO Y RIESGO DE SUICIDIO:

Puntuaciones de 0 a 5 en el LOT-R suelen asociarse a desesperanza clínica severa (Beck Hopelessness Scale), constituyendo un predictor crítico de riesgo autolítico. Explorar de inmediato ideación suicida con C-SSRS.

OPTIMISMO ILUSORIO O FANTASIOSO:

Puntuaciones máximas (24/24) asociadas a conductas de riesgo impulsivo, gastos desmedidos o negligencia médica pueden reflejar optimismo maníaco o anosognosia (descartar hipomanía con el cuestionario MDQ).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism: A reevaluation of the Life Orientation Test. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(6), 1063-1078.
2. Ferrando, P. J., Chico, E., & Tous, J. M. (2002). Propiedades psicométricas del test de orientación vital (LOT-R): Un estudio sobre la validez de constructo. *Psicothema*, 14(3), 673-680.
3. Remor, E., Amorós, M., & Carrobes, J. A. (2006). El optimismo y la experiencia de dolor crónico en pacientes con artritis reumatoide. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 38(2), 263-277.
4. Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2014). Dispositional optimism. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(6), 293-299.